

## FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

## MADRS · ESCALA DE DEPRESIÓN DE MONTGOMERY-ASBERG

*Montgomery-Asberg Depression Rating Scale — Patrón oro de evaluación clínica heteroaplicada de 10 ítems para monitorización terapéutica*

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

|                      |                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre Oficial       | Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS)                                                                                                        |
| Autores Originales   | Stuart A. Montgomery y Marie Asberg (1979) - Karolinska Institute / Guy's Hospital                                                                       |
| Validación Española  | Lobo et al. (2002) y Banco de Instrumentos de Bobes et al. (2004)                                                                                        |
| Tipo de Instrumento  | Entrevista clínica estructurada heteroaplicada por facultativo de salud mental                                                                           |
| Población Diana      | Pacientes adultos y mayores con diagnóstico clínico de depresión mayor                                                                                   |
| Tiempo de Aplicación | 12 a 20 minutos (administrada por clínico entrenado)                                                                                                     |
| Formato de Respuesta | Escala tipo Likert clínica de 7 anclajes: 0 a 6 puntos (anclajes descriptivos pares 0, 2, 4, 6)                                                          |
| Finalidad Clínica    | Cuantificación precisa de la severidad del episodio depresivo y monitorización longitudinal ultrasensible de la respuesta a psicofármacos o psicoterapia |

## 2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

A finales de la década de 1970, Stuart Montgomery y Marie Asberg identificaron que la célebre Escala de Hamilton (HDRS) presentaba una notable inercia métrica al evaluar cambios terapéuticos rápidos inducidos por nuevos antidepresivos. La HDRS incluía múltiples síntomas somáticos inespecíficos (estreñimiento, pérdida ponderal, insomnio de mantenimiento) que tardan semanas en normalizarse o que se ven distorsionados por efectos secundarios anticolinérgicos del propio fármaco.

Para superar este sesgo, los autores extrajeron de la Comprehensive Psychopathological Rating Scale (CPRS) los 10 reactivos clínicos que mostraron mayor poder estadístico de discriminación entre pacientes que respondían al tratamiento farmacológico y aquellos que recibían placebo. La MADRS prioriza así el núcleo afectivo, la reactividad emocional y la vivencia subjetiva del estado de ánimo depresivo, convirtiéndose en el instrumento de elección predilecto en los ensayos clínicos de fase III y IV de la neuropsicofarmacología contemporánea.

## 3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

| Dimensión Clínica       | Nº Ítems | Ítems Constituyentes y Manifestaciones Evaluadas                                                                                        |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afecto Triste y Tensión | 3 ítems  | Ítem 1 Tristeza observada, Ítem 2 Tristeza declarada por el paciente, Ítem 3 Tensión interna o angustia.                                |
| Patrón Vegetativo Clave | 2 ítems  | Ítem 4 Reducción del sueño (horas reales perdidas), Ítem 5 Reducción del apetito.                                                       |
| Funcionalidad Ejecutiva | 3 ítems  | Ítem 6 Dificultades de concentración intelectual, Ítem 7 Lاسitud o lentitud de inicio, Ítem 8 Incapacidad de sentir afecto (anhedonia). |
| Cognición Pesimista     | 2 ítems  | Ítem 9 Pensamientos pesimistas (culpa, ruina, autorreproches), Ítem 10 Pensamientos suicidas e ideación autolítica.                     |
| Puntuación Total MADRS  | 10 ítems | Suma directa de los 10 reactivos (Rango: 0 a 60 puntos).                                                                                |

## PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · MADRS

## 4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

|                                |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consistencia Interna</b>    | Alfa de Cronbach = 0.88 a 0.92 en la validación española de Lobo et al. (2002), demostrando una homogeneidad superior a la escala de Hamilton.                              |
| <b>Fiabilidad Inter-Jueces</b> | Coefficiente de correlación intraclase (ICC) = 0.89 a 0.95 entre clínicos evaluadores; los anclajes descriptivos detallados minimizan la discrepancia subjetiva.            |
| <b>Sensibilidad al Cambio</b>  | Capacidad estadística superior para detectar reducciones sintomáticas tempranas en las primeras 2 semanas de tratamiento antidepresivo en comparación con la HDRS y el BDI. |
| <b>Validez Concurrente</b>     | Correlación excelente con la Escala de Depresión de Hamilton ( $r = 0.88$ ), con la CGI-Gravedad ( $r = 0.85$ ) y con el inventario BDI-II ( $r = 0.78$ ).                  |

## 5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

- Calificación de Cada Ítem (0 a 6):**
  - La escala define textualmente anclajes en las puntuaciones pares: 0, 2, 4 y 6.
  - Si el estado del paciente se sitúa entre dos descripciones definidas, se le asigna la puntuación intermedia impar: 1, 3 o 5.
- Puntuación Total:** Suma de las calificaciones asignadas a los 10 ítems evaluados.
- Rango de Puntuación:** De 0 a 60 puntos totales.
- Criterio Estándar de Respuesta Terapéutica:** Reducción  $\geq 50\%$  respecto al valor basal previo.

## 6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

| Puntuación MADRS | Estratificación          | Gravedad Clínica      | Directriz Asistencial y Farmacológica                           |
|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 0 a 6 puntos     | Eutimia / Remisión       | Asintomático          | Remisión clínica completa. Mantenimiento profiláctico.          |
| 7 a 19 puntos    | Depresión Leve           | Leve / Subclínica     | Psicoterapia ambulatoria; evaluar indicación de fármacos.       |
| 20 a 34 puntos   | Depresión Moderada       | Cuadro Significativo  | Tratamiento farmacológico pleno con antidepresivos (ISRS/IRSN). |
| 35 a 60 puntos   | Depresión Severa / Grave | Incapacitante / Vital | Manejo hospitalario o intensivo; considerar potenciación o TEC. |

**CRITERIO INTERNACIONAL DE REMISIÓN COMPLETA (MADRS  $\leq 10$  /  $\leq 6$ ):** El consenso clínico estricto define la remisión plena como una puntuación MADRS  $\leq 6$  (otros estudios emplean  $\leq 10$ ). Mantener al paciente en puntuaciones entre 7 y 15 equivale a un estado de respuesta parcial con elevado riesgo de recaída y deterioro cognitivo residual.

## APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · MADRS

## 7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

**Paso 1: Establecimiento de Línea de Base:** Realizar entrevista clínica antes de iniciar o modificar la prescripción.

**Paso 2: Monitorización Evolutiva a las 2, 4 y 8 semanas:**

- **A las 2 semanas:** Un descenso  $\geq 20\%$  en MADRS es el predictor más potente de respuesta favorable a la 8.ª semana.
- **Si MADRS  $\leq 6$  a las 8-12 semanas:** Remisión exitosa. Mantener tratamiento de mantenimiento de 6 a 12 meses.
- **Si reducción  $< 50\%$  a la 6.ª semana:** Optimizar dosis, rotar a antidepresivo dual (venlafaxina, duloxetina) o asociar psicoterapia cognitivo-conductual.
- **Si MADRS  $\geq 35$  con persistencia de anhedonia grave:** Evaluar resistencia y pautar potenciación con litio o antipsicóticos de segunda generación.

## 8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

**Identificación:** Mujer de 41 años, abogada en ejercicio, en tratamiento con sertralina 50 mg/día prescrita por su médico de cabecera hace 4 semanas, remitida a psiquiatría por ausencia de mejoría y anhedonia paralizante.

**Evaluación Psicométrica Inicial en MADRS:** Total = 38 / 60 puntos (Depresión Severa).

- **Afecto y Tensión:** Llanto fácil en consulta (ítem 1 = 4); tristeza vivenciada como un peso físico intolerable (ítem 2 = 5); agitación angustiosa interna (ítem 3 = 4).
- **Anhedonia y Desánimo:** Incapacidad total para conectar afectivamente con sus hijos (ítem 8 = 5); dificultad para leer expedientes (ítem 6 = 4); lasitud física para levantarse (ítem 7 = 4).
- **Suicidio:** Desea no despertar pero niega planificación activa (ítem 10 = 2).

**Intervención Psiquiátrica:** La MADRS objetivó un fallo de respuesta a dosis submáximas de sertralina. Se tituló sertralina a 150 mg/día asociada a bupropión 150 mg/día para potenciar el tono dopaminérgico/noradrenérgico sobre la anhedonia. A las 2 semanas, la MADRS descendió a 26 puntos (reducción del 31.5%, indicando respuesta temprana favorable). A las 8 semanas, la puntuación total se situó en 4 puntos, con normalización afectiva y reincorporación a la actividad profesional.

## 9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

## ALERTA CRÍTICA EN ÍTEM 10 (SUICIDIO)

- Una puntuación  $\geq 4$  en el ítem 10 ("Considera el suicidio como una opción real o hace preparativos") requiere activar protocolo suicida urgente e internamiento.
- La escala debe reevaluarse semanalmente en pacientes con elevación del ítem 10 hasta alcanzar valor  $\leq 1$ .

## DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- **Depresión Atípica:** Hipersomnia e hiperfagia pueden no sumar en los ítems 4 y 5; valorar con inventarios específicos.
- **Depresión Bipolar:** Descartar antecedentes de episodios maníacos antes de escalar dosis de antidepresivos.

## 10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Montgomery, S. A., & Asberg, M. (1979). A new depression scale designed to be sensitive to change. *British Journal of Psychiatry*, 134(4), 382–389.
- Lobo, A., Chamorro, L., Luque, A., Dal-Ré, R., Badia, X., & Baró, E. (2002). Validación de las versiones en español de la Montgomery-Asberg Depression Rating Scale y la Hamilton Anxiety Rating Scale para la evaluación de la depresión y la ansiedad. *Medicina Clínica*, 118(13), 493–499.
- Hawley, C. J., Gale, T. M., & Sivakumaran, T. (2002). Defining remission by cut off score on the MADRS: Selecting the optimal value. *Journal of Affective Disorders*, 72(2), 177–184.
- Bobes, J., García-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3.ª ed.). Ars Médica.